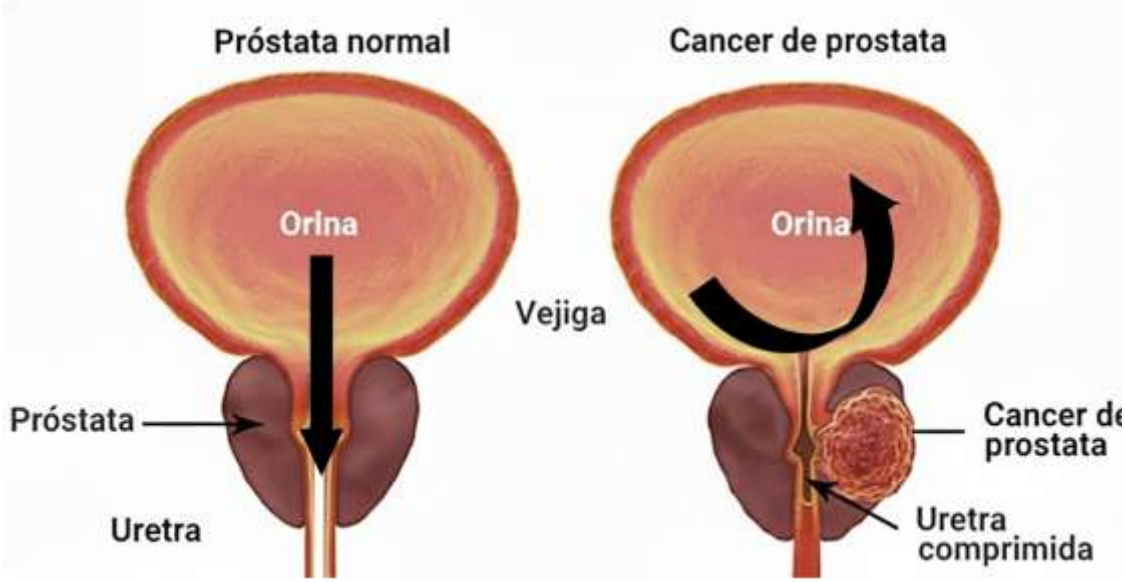
PROSTATECTOMÍA RADICAL

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Álvaro González Molinero, Juan José Gutiérrez Adrián, Ana Plata Bello

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

La prostatectomía radical es el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de próstata localizado, siendo su principal ventaja la posibilidad de curación produciendo el mínimo daño.

Tiene por objetivo la extirpación de la glándula prostática, así como el tejido que la rodea, incluyendo las vesículas seminales. En los casos de Ca de alto riesgo o sospecha de afectación de los ganglios linfáticos adyacentes, se realiza además una linfadenectomía pélvica.

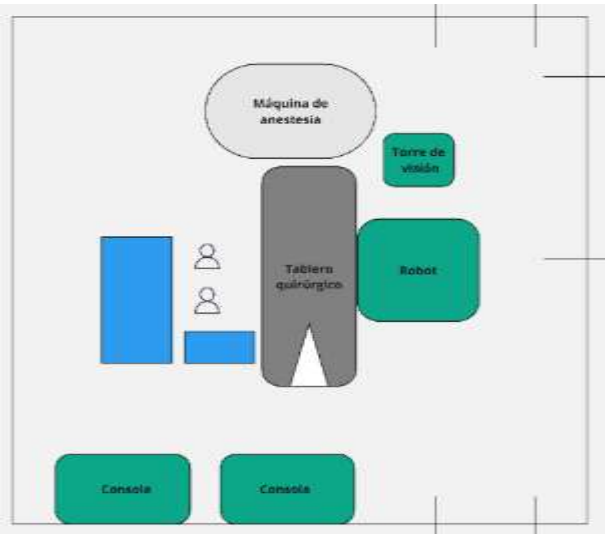


POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Supino con brazos alineados al cuerpo.
- Perneras bajas. No se quitan las perneras rectas del tablero. Bajar perneras para evitar contaminación y permitir acceso cómodo al SV.
- Almohada de silicona para la cabeza y colchón antideslizante.



POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

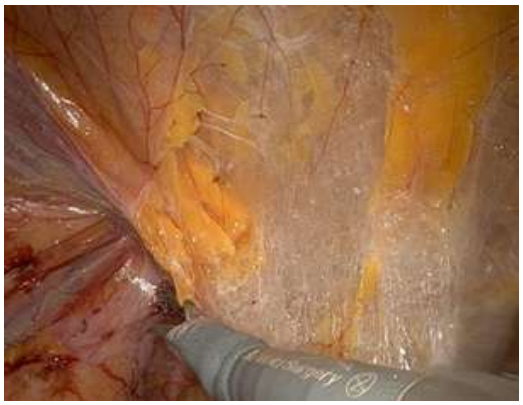


- Anatomía: pélvica
- Lado: izquierda
  - Brazo 1: Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar Maryland
  - Brazo 3: Óptica
  - Brazo 4: Monopolar
- Tablero quirúrgico:
  - Trendelemburg 30- 35°

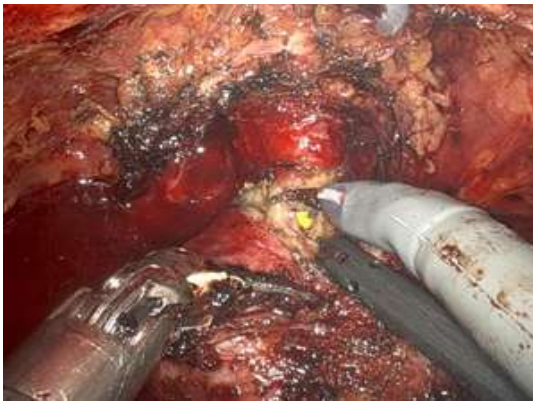
TÉCNICA QUIRÚRGICA

- Colocación del campo quirúrgico, teniendo en cuenta el orden de la asepsia de la piel: primero la zona abdominal y después la zona genital y perineal.
- Sondaje vesical con sonda de látex 18 ch de dos luces y vaciado de la vejiga.
- Colocación de trócares.
- Visualización de estructuras y liberación de adherencia si las hubiera.

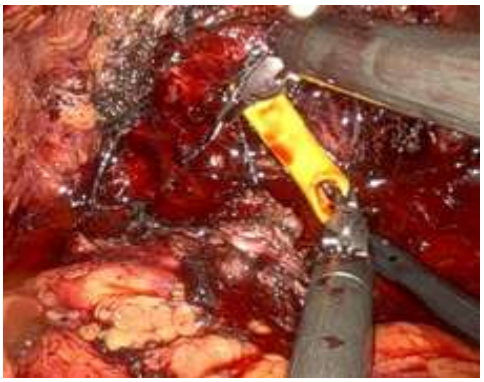
- En el caso de ser necesaria la linfadenectomía, éste sería el primer paso. Por el contrario, si no hay que hacerla, se comienza con el acceso al espacio de Retzius (espacio pre-vesical).

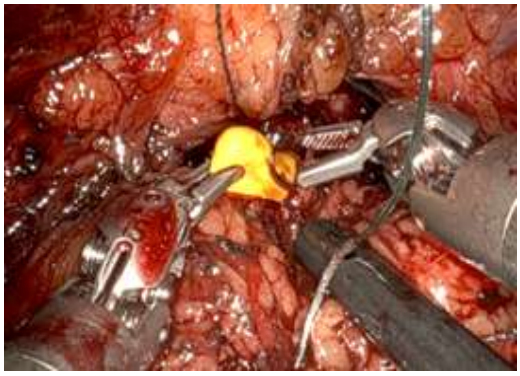



- Extracción de muestra de grasa periprostática.
- Sección del cuello vesical. Puede ser necesario una pequeña tracción de la sonda vesical para identificar mejor el cuello al marcarse en él, el globo de la sonda.
- Tras exponer y abrir el cuello vesical, se vacía el globo y se retira la sonda hasta dejarla insinuada.




- Disección de plano posterior, vesículas seminales y los conductos deferentes con su sección.
- Disección de plano anterior y uretra hasta poder desanclar la próstata.
- Preservación de las bandeletas con hemoclips de DV o hem-o-lok M en su defecto. La preservación de las bandeletas se realiza con el fin de minimizar el daño sensitivo.
- Se embolsa la pieza y se deja en cavidad.
- Se colocan dos porta-agujas en el robot brazos 2 y 4. Anastomosis vesico-uretral con dos suturas dobles tipo V-loc 3-0 anudado distalmente a 15 o 18 cm.





- Durante la anastomosis puede ser necesario el movimiento de la sonda para asegurar que no se estenosa la luz.
- En el último punto de la anastomosis se cambia la sonda de látex por la definitiva de silicona de 20 ch y tres vías, y se realizan lavados vesicales hasta la extracción de los coágulos y que el lavado salga limpio.
- Puede ser posible que se suture la sonda accidentalmente. Por ello hay que ser extremadamente cuidadoso al retirarla.
- Colocación de drenaje si es necesario, extracción de la pieza y cierre de heridas quirúrgicas.

NOTAS

En caso de linfadenectomía ampliada, las muestras que se suelen extraer son:

- Obturatriz izquierda/ derecha.
- Iliaca externa izquierda/ derecha.
- Iliaca común izquierda/ derecha.
- Iliaca interna izquierda/ derecha.



BIBLIOGRAFÍA

1. Binder J, Kramer W. Robotically-assisted laparoscopic radical prostatectomy. BJU Int. 2001;87(4):408-10. doi:10.1046/j.1464-410x.2001.00115.
2. Menon M, Tewari A, Peabody J. Vattikuti Institute prostatectomy: technique. J Urol. 2003;169(6):2289-92. doi:10.1097/01.ju.0000067443.10054.ca
3. Patel VR, Tully AS, Holmes R, Lindsay J. Robotic radical prostatectomy in the community setting—the learning curve and beyond: initial 200 cases. J Urol. 2005;174(1):269-72. doi:10.1097/01.ju.0000162039.30331.54.
4. Prostatectomía radical [Internet]. Dr. Felipe Vélez. Dr. Felipe Vélez Cárdenas; 2020 [citado el 16 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://drfelipevelez.com/prostatectomia-radical/